

R. Ferro García¹
M.C. García Ríos²
M.C. Vives Montero³

Un análisis de la adherencia al tratamiento en fisioterapia

Analysis of adherence with treatment in physiotherapy

¹Psicólogo clínico. Centro de Psicología CEDI. Granada.
²Fisioterapeuta. Profesora Asociada del Departamento de Enfermería. Universidad de Granada.
³Psicóloga. Profesora Asociada del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Granada.

Correspondencia:
María del Carmen García Ríos
Profesora Asociada del
Departamento de Enfermería
Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud
Universidad de Granada
Avda. Madrid, s/n
18071. Granada
E-mail: mcgríos@ugr.es

Fecha de recepción: 29/9/03
Aceptado para su publicación: 27/1/04

RESUMEN

Uno de los mayores problemas que afectan a las intervenciones en salud es la falta de adherencia al tratamiento. En Fisioterapia esto se agudiza por el costo y el esfuerzo que le supone al paciente cumplir con las prescripciones. El presente trabajo define el concepto de adherencia al tratamiento como la coincidencia entre el comportamiento de una persona y las prescripciones que ha recibido. También se analizan diez variables que influyen en esta adherencia. Además, se describen algunos estudios empíricos que han mejorado la adherencia en Fisioterapia. Finalmente, a modo de conclusión, se propone el uso de estas variables en la intervención fisioterapéutica para mejorar la adherencia a la misma.

PALABRAS CLAVE

Fisioterapia; Adherencia al tratamiento; Práctica clínica.

SUMMARY

One of major issues affecting health actuations is the lack of adherence with treatment. This is worsened in Physiotherapy, given the cost and effort that the treatment implies to the patient. The present work defines the concept of adherence with treatment as the coincidence of personal behavior and the treatment prescribed. Also ten variables having influence on this adherence are analyzed. Moreover, some empirical studies that have improved adherence in Physiotherapy are described. Finally, as a conclusion, the use of these variables in physiotherapical actuation in order to improve its adherence is proposed.

KEY WORDS

Physiotherapy; Adherence with treatment; Clinical practice.

334 INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas que afectan a los profesionales de la salud es la falta de seguimiento de las prescripciones en los tratamientos. Especialmente en el caso de la Fisioterapia esto se agudiza por el costo y el esfuerzo que le supone para el paciente el cumplir tales prescripciones. La mayoría de los pacientes en este campo sufren dolores o molestias al realizar el tratamiento, o en el caso contrario deben estar inmovilizados con el costo que supone no tener la suficiente autonomía. Ante este estado de la cuestión, los profesionales de la salud en este campo se encuentran indefensos o desmotivados para realizar su labor.

Por otro lado, los recursos de fisioterapia en el sistema de la Seguridad Social están desbordados por la demanda tan enorme que reciben, y esto obliga a los técnicos a establecer prioridades y a prescribir una serie de actividades y ejercicios por periodos prolongados de tiempo¹, dan las instrucciones de forma rápida y sin revisiones de mantenimiento que confirme el ajuste al tratamiento del propio paciente. Frecuentemente los profesionales de la salud prescriben las instrucciones en un lenguaje demasiado técnico que el paciente no entiende, de manera poco clara y muy rápidamente, puesto que el tiempo del que disponen para ver a los pacientes es breve. Además, no se aseguran que el paciente comprenda lo que se le pide y ni siquiera si es posible que lo haga. También por ejemplo, si se le requiere al paciente que haga una determinada dieta o ejercicio y no dispone de algunos de los instrumentos necesarios para el mismo. Esta forma de trabajo probabiliza la no adherencia al tratamiento en este campo.

En general, los datos de los estudios epidemiológicos publicados tanto en este país como fuera indican que los enfermos incumplen las prescripciones alrededor del 50 % de las veces en tratamiento de Fisioterapia^{1,2}. El porcentaje como se puede ver es bastante elevado, la mitad de estos pacientes no mejorarán y volverán de nuevo a las consultas, y por consiguiente saturarán las mismas impidiendo a los profesionales a trabajar en unas condiciones más óptimas. Volviendo de nuevo al comienzo del problema.

DEFINICIÓN DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Podemos definir la *adherencia a un tratamiento* como la coincidencia entre el comportamiento de una persona y los consejos sobre salud o prescripciones que ha recibido³. Es decir, hablamos de adherencia cuando el paciente cumple de forma adecuada con las instrucciones que el terapeuta le ha dado. Para referirse a este fenómeno se han utilizado términos como por ejemplo el seguimiento de órdenes o instrucciones, el ajuste al tratamiento, el cumplimiento de las prescripciones, etc. En este texto se utilizarán todas ellas como sinónimos del mismo. Ante la definición dada podríamos preguntarnos si hablaríamos de adherencia cuando el cliente realiza la actividad un tanto por ciento de las veces. Nos referimos al criterio de la respuesta de adherencia. Que debería de ser cercano al 80 % de las veces, ya que si fuese inferior los efectos o consecuencias del tratamiento se verían muy disminuidos. También se podría plantear la duración de esta adherencia por parte del paciente. El mantenimiento de la adherencia es una variable crucial, como en casi todo cambio conductual lo difícil es mantener la actividad. El mantenimiento de la adherencia debe ser definido claramente por el profesional que prescriba el tratamiento.

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Distintos autores se han planteado el problema de la adherencia y han intentado analizar las variables de las que depende (tabla 1). Se han seleccionado diez *variables* que influyen en la adherencia al tratamiento^{3,4}:

Estado motivacional del paciente

Imaginemos a un paciente que ha sufrido un traumatismo y que su lesión es irreversible. Pues bien, su motivación para realizar la tarea puede ser muy diferente a otro tipo de paciente que necesite la misma prescripción y cuyo pronóstico no es tan grave. Se ha observado en los servicios de Fisioterapia un porcentaje alto de pacientes (según nuestra experiencia un tercio de los pa-

cientes) que sufre de trastornos depresivos como secuelas de la lesión o del traumatismo⁵. Para este tipo de pacientes su motivación para realizar cualquier actividad es muy reducida. Está claro que una intervención que pretenda tener éxito debe trabajar con este tipo de variables. En algunos casos, el tratamiento psicológico de estos trastornos depresivos a veces será necesario realizarlo antes de la intervención fisioterapéutica. En general, se propone alertar a los profesionales de la salud de la posibilidad de que el paciente presente sintomatología depresiva y en cuyo caso sean tratados psicológicamente.

Aspectos desagradables o aversivos de la situación de consulta

Como antes se ha comentado las consultas de fisioterapia están masificadas, el tiempo de espera es elevado y el de consulta es breve, lo que es una contradicción. La motivación del propio profesional es baja y esto puede hacer que el trato no sea el más adecuado. La espera prolongada, la brevedad de la consulta, el trato poco cordial (por llamarlo de alguna forma) crean en el cliente una reacción contraria a la propia intervención. Parece obvio que intentar cuidar todo esto repercutiría en el éxito de la intervención. En fin, como propone B. Kohlenberg⁶, la propia relación terapéutica es una variable muy importante en el pronóstico de la terapia y nosotros diríamos que en la adherencia al tratamiento. Es decir, una buena relación terapéutica mejoraría el ajuste a las instrucciones del propio paciente.

Comprensión de las instrucciones

La mayoría de los pacientes que llegan a una consulta de Fisioterapia no son técnicos en la materia. Los profesionales de la salud tienden a explicar y dar instrucciones demasiado técnicas, probablemente por deformación profesional, y esto hace que paciente no entienda ni lo que le pasa ni lo que debe hacer para mejorar su situación. Hay que de adaptar la prescripción al repertorio verbal del paciente. Esto quiere decir que no solo hay que explicar con palabras poco técnicas lo que le pedimos sino adaptarlas a su capacidad verbal. No comprenden igual un funcionario de una ciudad que un agricultor

Tabla 1. Variables que afectan a la adherencia al tratamiento

Estado de motivación del paciente
Aspectos desagradables o aversivos de la situación de consulta
Comprensión de las instrucciones
La historia de interacciones entre el paciente y el profesional que da la prescripción
La especificación de las consecuencias de seguir las instrucciones y de no seguirlas
La incompatibilidad entre las actividades diarias del paciente y la propia prescripción
La complejidad de las acciones de la prescripción
La historia personal de seguir instrucciones
El tipo de consecuencias de las actividades prescritas y su distribución temporal
La aceptación del sufrimiento y del dolor como parte de la propia vida

de un pueblo. Por esto hay que asegurarse que la persona ha entendido lo que se le está requiriendo y para esto se recomienda que sea el propio paciente quien repita la prescripción con sus propias palabras. Cuando la instrucción es sencilla parece obvio que esto sea necesario.

La historia de interacciones entre el paciente y el profesional que da la prescripción

Esto es importante, en el sentido que se ha comentado anteriormente, en cuanto se debe generar una relación buena con el cliente. Si esta relación ya está deteriorada, aunque el profesional sea excelente, la terapia tenderá al fracaso.

La especificación de las consecuencias de seguir las instrucciones y de no seguirlas

La mayoría de las intervenciones no tienen en cuenta esta variable. No se suele describir las consecuencias que traerá no seguir las instrucciones y el seguirlas. Algo que será analizado posteriormente, es que la mayoría de las intervenciones requieren como poco un esfuerzo y cuando no un sufrimiento y dolor. Se debe exponer que a corto plazo estas serán las consecuencias pero que a largo plazo sus consecuencias serán otras. A decir verdad, la

- 336 mayoría de estas consecuencias a largo plazo no son mas que no sentir nada o encontrarse como antes, aunque se denominen “sentirse bien”. Si el paciente no es consciente de lo que le “costará” recuperarse, puede que deje el tratamiento.

La incompatibilidad entre las actividades diarias del paciente y la propia prescripción

Imaginemos que el paciente es una persona muy activa y la tarea del tratamiento consiste en hacer reposo en su casa, lo más probable es que no exista la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, es tarea del profesional buscar una solución entre ambas actividades. Como en el caso descrito en Herruzo y Ferro², donde se prescribió reposo a una niña coincidiendo con sus dibujos animados preferidos en televisión para probabilizar el seguimiento de la instrucción del paciente.

La complejidad de las acciones de la prescripción

La complejidad de las tareas es una variable que parece clara a la hora de ajustarse a las instrucciones recibidas. Es más probable seguir una instrucción sencilla que una compleja. En esta variable afecta el tipo de población a la que va dirigido el tratamiento. En personas mayores y en niños las instrucciones deberán ser lo más simples posibles para probabilizar su seguimiento. Una forma asegurarse que se seguirán estas prescripciones es comprobar si estas acciones formarían parte de las habilidades del paciente, por el propio terapeuta, ya sea preguntando al paciente o realizando un ensayo en la propia consulta.

La historia personal o repertorio de seguir instrucciones del propio paciente

Entre los sujetos hay muchas diferencias a la hora de seguir instrucciones, hay personas que han sido educadas para ajustarse y seguir cualquier orden que se les dé. En cambio, hay otras que seguir instrucciones no forma parte de su repertorio conductual, son personas independientes que no hacen caso de consejos, etc. Con este tipo de población hay que intentar otras formas de in-

tervenir. Una prueba que es utilizada en psicoterapia⁷ y que nos ayuda a comprobar si el paciente sigue o no instrucciones, es pedirle al paciente que intente escribir algo en la propia consulta, y esto sirve como prueba de cómo sigue las instrucciones. Podremos sospechar si cumplirá o no con las tareas encomendadas.

El tipo de consecuencias de las actividades prescritas y su distribución temporal

El tipo de consecuencias por seguir las instrucciones pueden ser: desagradables o aversivas y gratificantes o reforzantes. Pensemos que la orden puede ser estar tumbado o realizar un determinado movimiento que produce dolor. También pueden recibirse consecuencias de tipo social como alabanzas, etc. por realizar la tarea. Por otro lado, la distribución temporal de estas consecuencias puede ser: inmediata o demorada. Por ejemplo, la molestia o el dolor se produce de manera inmediata, las alabanzas pueden ser demoradas. Pues bien, esta variable afecta en gran manera al hecho de seguir la instrucción. Está claro que es más probable seguir una orden que tenga consecuencias agradables que las tenga aversivas. Además, las consecuencias inmediatas controlan mejor la conducta que las demoradas. Es decir si lo que le sigue a la actividad es molestia o dolor es menos probable que se realice aunque después alguien le diga lo bien que lo hace o que simplemente mejore a medio plazo con esa actividad.

Aceptación por parte del paciente de que el dolor y el sufrimiento forma parte de la vida

La mayoría de los pacientes que van a este tipo de consultas quieren una vida “anestesiada”, sin dolor, sin sufrimiento, ni esfuerzo, llena de satisfacción y de placer. Pero esa visión existencial es poco realista. La mayoría de las prescripciones que dan los profesionales en Fisioterapia, suponen como poco un esfuerzo por parte del cliente. Cuando no, requieren sentir dolor y padecer sufrimiento. Por parte de los profesionales de la salud esto se suele ocultar, negando la parte de dolor e incluso, ignorándolo. Se ha demostrado que intervenciones basadas en la aceptación del dolor son más efectivas que el con-

trol racional a la hora de tolerar el dolor⁸, y que estos procedimientos basados en la aceptación del propio dolor o sufrimiento, son eficaces en el tratamiento del dolor crónico^{9,10}. Por lo tanto, proponemos que se trabaje la aceptación de que el dolor forma parte de la curación. Pero antes que nada habría que preguntarse: ¿qué se entiende por aceptación? Según Ferro¹¹, la aceptación consiste en no evitar, controlar o cambiar los elementos que forman parte de una contingencia, es decir un contexto, una conducta, las respuestas emocionales y los pensamientos y las consecuencias de todo esto; y no intentar evitarlos, controlarlo o cambiarlos. Aplicado a este campo, sería admitir o tolerar que la realización de una determinada actividad o la presencia de una lesión o traumatismo produce dolor o sufrimiento, tanto físico como psicológico. Se ha comprobado que si se intenta luchar contra este tipo de sensaciones, lo que se consigue es el efecto contrario^{12,13}. Cuanto más luchemos contra el dolor más conscientes del mismo seremos y más nos dolerá. Esto no es una visión masoquista de la vida, los analgésicos son eficaces pero en determinados casos no, y es en estos casos donde intervenir desde la aceptación es una alternativa. Al prescribir una tarea que como poco genera molestias, es eficaz realizarla aceptando que esta molestia forma parte de la curación.

ESTUDIOS SOBRE LAS MEJORAS EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA

Como mantienen Herruzo, Luciano et al¹ las intervenciones dirigidas a incrementar la adherencia a las prescripciones de fisioterapia son aún muy escasas. Algunas de estas intervenciones se realizan en el propio hospital, lo que favorece la adherencia pues hay mayor control del seguimiento y del mantenimiento. En cambio, todavía son más escasas las intervenciones en régimen de ambulatorio, donde las visitas al profesional son esporádicas y se suelen prescribir las tareas en la casa. En esta última línea se encuentra el trabajo de Herruzo y Ferro², donde una niña de 10 años con una hemiplejia izquierda como secuela de una intervención de un astrocitoma que se negaba a seguir las prescripciones del fisioterapeuta. La instrucción era que debía permanecer

tumbada al menos una hora diaria. La intervención entre otras cosas, consistió en organizar el tiempo de estar tumbada con el de su programa de televisión favorito. Además los autores comprobaron que tanto la madre como la niña comprendieron todas las instrucciones. Con esta intervención se consiguió un cumplimiento de la prescripción del 100 % de las veces. Como se puede ver, esta intervención tuvo en cuenta las variables que se han visto anteriormente.

Por otro lado, los estudios que demuestren la eficacia también son muy escasos. Uno de los estudios dedicados a demostrar la mejora de la adherencia al tratamiento en Fisioterapia es el trabajo de Waggoner y LeLievre¹⁴. En el que consiguieron aumentar la adherencia a realizar una tabla de ejercicios para realizar en la casa en pacientes artríticos, utilizando un dispositivo electrónico que registraba el número de veces que realizaban los ejercicios y una vez en la consulta de revisión el profesional administraba consecuencias sociales respecto al número realizado. Otro de estos estudios dedicados a mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes quemados fue el de Hegel, Ayllon, Vander Plate y Spiro-Hawkins¹⁵. Como mantienen los propios autores, la intervención en pacientes quemados es necesaria porque las heridas abiertas sufren contracturas y cicatrización hipertrófica, la prolongada hospitalización conduce a la atrofia de las fibras musculares, etc. Este estudio se realizó para mejorar la adherencia a los auto-ejercicios de los pacientes quemados adultos. La intervención para la mejora de la adherencia a los ejercicios consistió en que cada sujeto debía de registrar en un gráfico sus avances, establecer diariamente un objetivo a realizar y en cada sesión se medía el movimiento de articulación que podía realizar el paciente. Se evaluó con un diseño de línea base múltiple, en el que se comprobó que esta intervención fue más eficaz que la tradicional en estos casos. Finalmente, uno de los estudios que se han analizado parte de las variables antes señaladas, es el de Herruzo, Luciano, Salinas y Muñoz¹. En este trabajo experimental, se compara un procedimiento tradicional de intervención en fisioterapia frente a un procedimiento alternativo en el que se tenía en cuenta algunas de estas variables (ejercicios en el hospital y en casa, adaptación de las instrucciones, administración de consecuencias, uso del cónyu-

- 338 ge en el tratamiento). Como era de esperar, los resultados indicaron que el procedimiento que atendía estas variables fue más efectivo que el tradicional.

CONCLUSIONES

Después de todo lo mencionado anteriormente parece claro que el problema de la adherencia al tratamiento en Fisioterapia es un problema importante. Mejorándola podría conseguirse una mejora en los servicios de Fisioterapia por dos razones. Por un lado, disminuyendo los pacientes reincidentes en consulta (recordemos que son el 50 %) y por otro, mejorando la propia intervención terapéutica.

La adherencia a las órdenes del terapeuta y el mantenimiento de la actividad cuando es necesario es pobremente estudiada por los investigadores en ciencias de la salud. Como mantiene Herruzo³ la mayoría de las intervenciones fallan al ser retiradas, fallando el mantenimiento de las mismas. La importancia del presente trabajo radica en realizar un análisis de las variables que se creen que son relevantes y una revisión de los estudios encontrados que han estudiado y aplicado estas variables en su intervención.

Tener en cuenta el estado motivacional del paciente, los aspectos de la consulta, la propia comprensión de las órdenes, la relación entre el terapeuta y el paciente,

las consecuencias de seguir las instrucciones, analizar la vida del paciente y adaptar las instrucciones a ella, y la aceptación de que el esfuerzo y el sufrimiento forman parte de la cura, parece que obviamente mejorarían el cumplimiento o el ajuste a la propia prescripción. Pero se podría decir por parte de los profesionales en fisioterapia que ellos no pueden dedicarse a realizar todo este tipo de actividades porque aumentaría el tiempo que pueden dedicarse a cada caso. Pensamos que esto es un error una buena intervención garantizando su seguimiento permitiría aumentar el éxito de la misma y la reducción de los pacientes reincidentes.

Como ya se analizó el tipo de patología de los pacientes juega una baza importante en la adherencia al tratamiento, no es lo mismo ejercicios de fisioterapia donde el propio paciente ve sus progresos que tienen unas consecuencias inmediatas con pacientes como los del caso de fisioterapia lumbar donde su estado motivacional para realizar los ejercicios y su adherencia es bien diferente.

Parece obvio que se necesite mejorar el estudio de todas estas variables y de la aplicación de las mismas en trabajos con un suficiente control experimental.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Dr. Antonio García Ríos la traducción del resumen al inglés.

BIBLIOGRAFÍA

1. Herruzo J, Luciano MC, Salinas I, Muñoz J. Intervención conductual en Fisioterapia: Estudio comparativo de dos procedimientos diseñados para incrementar la probabilidad de adherencia a las prescripciones médicas. *Revista Española de Terapia del Comportamiento* 1990;8(2):189-206.
2. Herruzo J, Ferro R. Mejora de la adherencia al tratamiento en un paciente con discapacidad física. *Análisis y Modificación de Conducta* 1991;17(51):107-13.
3. Herruzo J. Evaluación e intervención en adherencia a prescripciones médicas y de salud (1). *Análisis y Modificación de Conducta* 1990;16(48):193-208.
4. Luciano MC, Herruzo J. Some relevant components of adherence behavior. *Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry* 1992;23(2):117-24.
5. Herruzo J, Luciano MC, Ferro R. Atención primaria en psicopatología de la discapacidad e invalidez. Una experiencia en la Seguridad Social. *Análisis y Modificación de Conducta* 1991;17(52):215-27.
6. Kohlenberg B. Emotion and the relationship in psychotherapy: a Behavior Analytic Perspective. En: Dougher MJ, editor. *Clinical Behavior Analysis*. Reno: Context Press, 2000; p. 271-89.
7. Kohlenberg RJ, Kanter JW, Bolling MY, Parker CR. Enhancing Cognitive Therapy for Depression with Functional Analytic Psychotherapy: Treatment Guidelines and Empirical Findings. *Cognitive and Behavioral Practice* 2002;9:213-29.
8. Hayes SC, Bissett RT, Korn Z, Zettle RD, Rosenfarb IS, Cooper LD, Grundt AM. The impact of acceptance versus control rationales on pain tolerance. *The Psychological Record* 1999;49:33-48.

9. Augustson EM. Issues of acceptance in chronic pain populations. *The Behavior Analyst Today* 1999;1:14-7.
10. Luciano MC, Visdómine JC, Gutiérrez O, Montesinos F. ACT (terapia de aceptación y Compromiso) y dolor crónico. *Análisis y Modificación de Conducta* 2001;27(113):473-501.
11. Ferro R. La aceptación y la Terapia de Conducta. *Análisis y Modificación de Conducta* 1998;24(94):217-37.
12. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. *Acceptance and Commitment Therapy. An experiential approach to behavior change*. New York: Guilford Press, 1999: p. 60-1.
13. Wilson K, Luciano MC. *Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Un tratamiento conductual orientado a los valores*. Madrid: Pirámide, 2002.
14. Waggoner CD, LeLieuvre RB. A method to increase compliance to exercise regimens in rheumatoid arthritis patients. *Journal of Behavioral Medicine* 1981;4:191-201.
15. Hegel M, Ayllon T, Vander Plate C, Spiro-Hawkins H. A behavioral procedure for increasing compliance with self-exercise regimens in severely burn-injured patients. *Behaviour, Research and Therapy* 1986;24:521-8.

339